

DEMENCIA PRECOZ O EL GRUPO DE LAS ESQUIZOFRENIAS

PREFACIO DEL AUTOR E INTRODUCCIÓN GENERAL — TEXTO ÍNTEGRO Y COMPLETO · Eugen Bleuler (1911)

Traducción castellana oficial: Daniel Ricardo Wagner · Ediciones Hormé / Paidós (Buenos Aires)

Título original: *Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien* (Leipzig y Viena, Franz Deuticke, 1911)

Asignación académica: Clase 2 — Historia y paradigmas de la psiquiatría (Psicopatología I · UFLO Online 2026)

PREFACIO DEL AUTOR

Nuestro conocimiento del grupo de enfermedades que estableció Kraepelin bajo el nombre de «Dementia Praecox» es demasiado reciente para autorizar una descripción completa. En su conjunto, es todavía demasiado fluido, incompleto y provisorio. Dado que sería bastante tedioso mencionar todas las reservas que implica este hecho, espero estar justificado al suponer que el lector lo tendrá presente.

Una dificultad adicional se suscita respecto a los capítulos sobre psicopatología, y ella es el estado embrionario de la psicología contemporánea. Ni siquiera poseemos la terminología necesaria para los nuevos conceptos psicológicos. Todos los términos que empleamos pueden tener diversos significados. Quien no se tome el trabajo de seguir con atención el pensamiento del autor, llegará pronto a entender un término determinado en un sentido distinto del que el autor le dio, y obtendrá así una imagen errónea del tema.

Si a pesar de estas dificultades intento aclarar algunas relaciones y conceptos psicológicos, no lo hago meramente porque cada hecho nuevo sea de valor en sí mismo, sino principalmente porque parece que, en la presente situación de nuestro conocimiento, puede conseguirse de este modo una nueva comprensión de la naturaleza de las psicosis. Por consiguiente, los diversos aspectos de esta enfermedad recibirán una consideración bastante desigual. Los principios que todo psiquiatra entiende claramente serán simplemente enunciados, mientras que los puntos menos familiares tendrán su introducción, discusión y ejemplificación. Por tanto, en esta obra tuve que sacrificar los fines estéticos a los prácticos. Asimismo, difícilmente podrán evitarse las repeticiones, puesto que, dada la complejidad de la psique humana, procesos semejantes se presentan en los contextos más diversos.

La idea de la *dementia praecox* deriva en su totalidad de Kraepelin. A él le debemos también, casi exclusivamente, el agrupamiento y descripción de los distintos síntomas. Sería demasiado fatigoso reconocer nuestra deuda hacia él en cada uno de los casos, de modo que espero que esta observación suplirá todas las omisiones subsiguientes.

Un aspecto importante del intento de perfeccionar y ampliar los conceptos de la psicopatología es precisamente la aplicación de las ideas de Freud a la *dementia praecox*. Estoy seguro de que todo lector se da cuenta de cuán grande es nuestra deuda respecto a este autor, sin necesidad de que yo mencione su nombre en todos los puntos apropiados de la exposición. Deseo agradecer también a mis compañeros de trabajo de Burghölzli, de quienes mencionaré solamente a Riklin, Abraham, y en especial a Jung. Sería imposible establecer con precisión quién proporcionó tal o cual idea u observación.

Me pareció de escaso valor pasar revista a toda la literatura dado que ello sería casi imposible, pues tendría que incluirse prácticamente a toda la literatura psiquiátrica; en alguna medida, casi todas las obras sistemáticas sobre psiquiatría han tocado lo que hemos llegado a considerar como el problema de la *dementia praecox*. Sólo las publicaciones más recientes tienen algún valor; muchas de ellas son interesantes solamente en cuanto revelan cuán erróneamente puede ser interpretado un concepto excelente. En mi opinión, sería una desconsideración hacia el lector citar las prioridades para cada uno de los puntos de menor importancia; he procedido de acuerdo con ello.

Esta obra se completó en el verano de 1908, pero publicaciones posteriores ofrecieron oportunidades para efectuar correcciones y agregados. Los números entre paréntesis se refieren a la bibliografía que proporcionamos en el apéndice.

INTRODUCCIÓN GENERAL

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La observación de que una enfermedad aguda puede tener por resultado un daño permanente del órgano afectado ha tenido en la psiquiatría una importancia mucho mayor que en cualquier otro campo de la medicina. Nuestras instituciones de salud mental han estado siempre llenas con las víctimas de las denominadas enfermedades «secundarias». De modo que se ha convertido en una cuestión vital la de saber cuáles de las formas agudas de la enfermedad culminan en estados incurables y cuáles no. Hasta el presente, todas las formas agudas descritas de las «psicosis simples» podían terminar en la recuperación o bien conducir a formas «secundarias».

Kraepelin consiguió, finalmente, aislar un cierto número de síntomas presentes en afecciones con prognosis muy pobres, y ausentes en otros grupos de enfermedades. Las psicosis caracterizadas por la presencia de esos síntomas fueron reunidas bajo el término «Dementia Praecox». Sin embargo, siempre hubo algunos casos que aunque exhibían estos síntomas parecían llegar a la recuperación. No obstante, se ha adquirido el conocimiento de que cierto grupo de síntomas indica una tendencia al deterioro (demencia). Por otro lado, otras afecciones agudas donde faltaban estos síntomas no parecían culminar nunca en daños secundarios. Éstas fueron reunidas bajo el término de psicosis maniaco-depresivas. Desde un punto de vista práctico y teórico, esta clasificación ofreció una gran ventaja, dado que proporcionó una base para hacer predicciones, en un gran número de casos, respecto a los ataques agudos y al estado terminal. Por la presencia del complejo de síntomas así seleccionado y definido, se caracteriza como una unidad al amplio grupo de la demencia praecox.

Muchos se oponen todavía a la concepción de Kraepelin; algunos son desconcertados por las múltiples manifestaciones clínicas externas que presenta esta enfermedad, otros no pueden contentarse con el concepto de una afección que parecía estar definida originariamente por el curso que le es peculiar, pero que incluye casos con desenlaces tanto buenos como malos. Sin embargo, un examen más atento demuestra que, en realidad, todos estos casos tienen mucho en común, que ellos son claramente distinguibles de otros tipos de enfermedad mental. Esto constituye ciertamente un gran progreso en relación a los anteriores intentos de definir este grupo patológico. Aunque no siempre esta afección tiene por resultado un completo deterioro, cada uno de los casos revela empero, ante una indagación más acuciosa, algunos importantes síntomas residuales que son comunes a todos. De modo que, además de una idéntica sintomatología, encontramos también los mismos resultados finales, no cuantitativamente sino cualitativamente, es decir, en términos de la dirección en que se desarrolla la enfermedad. Otras psicosis no muestran ni la misma sintomatología ni el mismo desenlace. A la inversa, todas las psicosis a las que se consideró hasta ahora como secundarias exhiben el mismo complejo general de síntomas. Por lo tanto, en el presente estado de nuestro conocimiento, la delimitación de este grupo patológico no sólo es permisible sino que se impone como obligatoria.

Además, se ha establecido que todas aquellas formas de deterioración que comienzan lenta e insidiosamente, sin ninguna fase aguda ostensible, tienen los mismos síntomas y no pueden ser distinguidas en ningún momento de los llamados tipos secundarios. De modo que debemos incluir en esta enfermedad a todos aquellos tipos conocidos por una amplia variedad de nombres, tales como «deterioración primaria», «paranoia deteriorante», etc. Hasta ahora, han fracasado completamente todos los intentos de clasificar a estos casos en subdivisiones o grupos según sus cuadros clínicos externos.

Bajo el término demencia precoz o esquizofrenia incluimos entonces a un grupo de enfermedades que pueden distinguirse claramente de todos los otros tipos patológicos en el sistema de Kraepelin. Aquéllas tienen muchos síntomas comunes y prognosis semejantes. Sin embargo, sus cuadros clínicos pueden ser extraordinariamente diversos. Quizás este concepto tenga meramente un valor temporario, en la medida en que más adelante tenga que ser reducido (en el mismo sentido en que los descubrimientos de la bacteriología hicieron necesaria la subdivisión de las neumonías en términos de los diversos agentes etiológicos). No obstante, el concepto de la demencia precoz ha obtenido un progreso aún mayor que el efectuado con el descubrimiento de la etiología de la paresia general. También este último síndrome fue oscurecido durante mucho tiempo por muchos otros conjuntos de síntomas. Pensamos que el problema de la demencia precoz afecta mucho más profundamente a todo el cuerpo de la sistemática de todas las psicosis que en su época el problema de la paresia general. Aquellos hechos que todavía siguen siendo oscuros no involucran ya a la parte principal de los casos de demencia precoz, sino a las formas excepcionales y

difíciles, como la psicosis febril, que hasta ahora ha resistido al estudio más atento. Por primera vez tenemos definiciones que nos permiten conseguir alguna comprensión común. Además, sabemos en qué sectores nuestro conocimiento y medios de investigación actuales no nos permiten trazar líneas claras.

El desarrollo del concepto de la demencia precoz constituye una parte considerable de toda la evolución de la psiquiatría teórica. Ésta puede difícilmente ser descrita sin aquél. Por lo tanto, no es posible intentar una exposición completa de la génesis del concepto de la demencia precoz. La cuna de la idea fue la quinta edición de la «Psiquiatría» de Kraepelin (1896). Por supuesto, se sabía desde hace largo tiempo que algunas psicosis agudas experimentan mejorías, mientras que otras tienden a convertirse en crónicas. También se había observado y conocido durante mucho tiempo que los más simples casos de deterioración pueden llegar a tal estado sin exhibir síntomas agudos. Ya Esquirol había separado la idiotez «adquirida o accidental» de la hereditaria o congénita. Él notó el comportamiento estereotipado de algunos de sus pacientes. Además, desde hace tiempo se sabe que tales procesos de deterioración afectan principalmente a personas jóvenes. Fue por esta razón que Morel acuñó el nombre de «*démence précoce*» (demencia precoz).

Sin embargo, no pudo descubrirse ningún denominador único en el caso de los abigarrados cuadros clínicos de los procesos deteriorantes. Un gran obstáculo para este fin fue la ingenua creencia (muy extendida hacia la mitad del último siglo) de que las psicosis, o más bien la psicosis, debe tener un curso muy definido que, según se suponía ordinariamente, comienza con un estado melancólico. Esta noción vició también a las teorías de Kahlbaum, que en otros aspectos significaron un progreso esencial. Naturalmente, varias mentes sagaces, aun antes que él, sabían ya que los viejos nombres, tales como melancolía, insanía, manía, delirios, designaban meramente a cuadros de síntomas. Sin embargo, no se podía aislar a verdaderos procesos patológicos; por consiguiente, se trataba a las entidades sintomatológicas como si ellas correspondieran a enfermedades reales.

Kahlbaum fue el primero que realizó un esfuerzo consciente por clasificar procesos patológicos a partir de este conjunto de síntomas. En 1863, en su «Agrupamiento de las enfermedades psíquicas», llamó la atención sobre el complejo de síntomas catatónico, pero recién en el año siguiente describió la enfermedad con mayor precisión bajo este nombre, y por fin la estableció definitivamente en su monografía de 1874. Según él, la catatonía atraviesa los estados de melancolía, manía, estupor, confusión y, finalmente, demencia (análoga a lo que él denominó *vesania típica*). Cualquiera de estas diversas etapas puede faltar, y la curación puede conseguirse en cualquiera de ellas menos la última. El autor caracterizó a la enfermedad (correspondiente a la paresia general) mediante un grupo de síntomas corporales que ahora consideramos como manifestaciones catatónicas. Desde ese período, la catatonía, en cuanto proceso patológico, nunca desapareció de la literatura, aunque a menudo se la atacó vigorosamente. Sólo unos pocos autores aceptaron el concepto de catatonía como un «proceso patológico»; la mayoría de los psiquiatras alemanes lo rechazaron, principalmente debido a la muy obvia razón de que el curso típico, tal como fuera postulado por Kahlbaum, era la excepción y no la regla, y además porque el concepto no parecía estar suficientemente delimitado en ninguna dirección.

En 1871, Hecker, siguiendo una sugestión de Kahlbaum, describió a la hebefrenia, que éste incluyó entonces en su grupo catatónico, y luego amplió a todo el grupo para incluir al heboide, que no es más que una forma moderada de la hebefrenia que se manifiesta principalmente en cambios de carácter. En una fecha temprana, Schüle pudo describir a la catatonía como «una hebefrenia en conjunción con neurosis de tensión». En contraste con Kahlbaum, muchos autores pusieron a las psicosis deteriorantes (demenciales) en una relación más estrecha con las degeneraciones, tanto familiares como individuales. Con anterioridad, Morel había planteado el problema de la importancia causal de la herencia. Se creyó entonces que un cerebro defectuoso estaba especialmente predispuesto a esta enfermedad.

Algo después que la catatonía y la hebefrenia, la deterioración simple (que a menudo había sido diagnosticada en la práctica, pero rara vez descrita) fue estudiada más cuidadosamente por Pick en 1891, y especialmente por Sommer. Fue este último quien, tres años después, ofreció una excelente descripción, no sólo del síndrome clínico catatónico, sino también de las diversas demencias primarias, en las que incluyó a la hebefrenia. De tal modo amplió el concepto adecuadamente, puesto que incluyó a los síndromes paranoides deteriorantes en el concepto de «demencia primaria». Sin embargo, en su clasificación final todavía separa a la catatonía de estos tipos de deterioración. Las ideas y la clasificación de Kahlbaum encontraron escaso apoyo fuera de Alemania.

Aun Ségla y Chaslin, quienes habían sido los primeros en interesarse profundamente por el problema de la catatonía, llegaron a la conclusión de que era un complejo de síntomas, y no una enfermedad propiamente dicha. En Inglaterra sólo más tarde se concedió atención al tema.

En 1896, Kraepelin incluyó a las «psicosis deteriorantes» en un grupo de enfermedades que, según creyó, eran esencialmente trastornos metabólicos. Al principio, aplicó el término demencia precoz (que adoptó nuevamente) solamente a las hebefrenias, y a los que otros autores habían denominado los síndromes demenciales primarios. Llamó catatonía primaria a todas las formas con síntomas catatónicos predominantes, mientras que bajo el nombre de «dementia paranoides» describió a una forma no muy frecuente, con una rápida erupción de alucinaciones e ideas delirantes confusas, comportamiento exterior relativamente intacto, y una temprana detención de todo el proceso. Tres años más tarde incluyó a todo el grupo deteriorante bajo el término de demencia precoz. La catatonía retuvo su significado usual; aquello a lo que se denominó anteriormente demencia precoz fue ahora incluido esencialmente en la hebefrenia; mientras que —y éste fue el paso más importante— incluyó en la forma paranoide de la demencia precoz a la anteriormente denominada Paranoia alucinante o fantástica.

Desde ese momento, el alcance del concepto de demencia precoz ha seguido siendo esencialmente el mismo. Se registró un solo desarrollo ulterior: Kraepelin se retiró un tanto de su anterior posición, en la que había acentuado muy fuertemente que el curso de la enfermedad siempre termina en deterioración. Ahora consideró que también pertenecen al grupo de la demencia precoz los muchos casos que, al menos para todos los fines prácticos, pueden ser curados permanentemente o bien detenidos durante períodos muy largos. Durante un largo tiempo, la controversia psiquiátrica giró en torno a los síntomas más bien que alrededor del concepto de Kraepelin; en la actualidad, empero, parece existir una marcada tendencia a descuidar estos síntomas catatónicos en favor del estudio y discusión de los trastornos de la asociación y de la afectividad.

Paralelamente a la elaboración del concepto de demencia precoz, fueron definidas otras entidades patológicas, en particular la psicosis maniaco-depresiva. De este modo se otorgó a la demencia precoz un relieve nítido; sus límites ya no fueron trazados unilateralmente desde adentro, sino también sólidamente desde el exterior.

II. EL NOMBRE DE LA ENFERMEDAD

Desgraciadamente, no podemos eludir el incómodo deber de acuñar un nuevo nombre para esta enfermedad. Pues el actual es demasiado inapropiado. Sólo designa a la enfermedad y no al enfermo; además, es imposible derivar de él un adjetivo que denote las características de la afección, aunque un colega exasperado ha utilizado «síntoma precoz». Sin un término nuevo, una obra concienzuda sobre diagnóstico diferencial sería difícil de escribir, y aún más difícil de leer.

Pero hay una razón mucho más importante y práctica por la que me parece inevitable proponer una nueva designación al lado de la antigua. Ésta última es producto de una época en la cual no sólo el concepto de demencia, sino también el de precocidad, eran aplicados a todos los casos que se tenían a mano. Pero se adecúa difícilmente a nuestras ideas contemporáneas sobre el alcance de esta entidad patológica. Actualmente incluimos a pacientes a los que no llamaríamos «dementes» ni tampoco víctimas de una deterioración temprana, exclusivamente. Teniendo en cuenta el hecho de que Kraepelin describió de un modo clásico exactamente lo que quería decir con el término, podríamos considerar irrelevante al significado original de «dementia praecox». Después de todo, hablamos actualmente de «melancolía» sin que nos perturben las antiguas ideas sobre la «bilis negra». No hay que atribuir a la ciencia de la psiquiatría el que no sea éste el caso. Por su mismo nombre, la «psicosis periódica» de Kraepelin ha cerrado muchas puertas que estaban abiertas al término «locura maniaco-depresiva», pues hubo psiquiatras que bajo ninguna circunstancia podían ser inducidos a designar como «periódica» a una enfermedad que en ciertas condiciones sólo se manifiesta con unos pocos ataques, o quizás inclusive con sólo un ataque aislado, en el curso de toda una vida.

En cuanto a la designación «demencia precoz», las cosas están todavía peor. Difícilmente haya un solo psiquiatra que no haya escuchado el argumento de que todo el concepto de demencia precoz debe ser falso, puesto que hay muchos catatónicos y otros tipos que, desde el punto de vista de los síntomas, deberían ser incluidos en la demencia precoz de Kraepelin, y que no llegan a una deterioración completa. Asimismo, parecería que se pone fin a toda la cuestión con la demostración de que en un caso

particular el deterioro no aparece precozmente, sino más tarde. También se identifica a menudo al concepto de la demencia precoz con el de una determinada forma de psicosis de las personas jóvenes; y dado que puede demostrarse muy fácilmente que hay muchas otras enfermedades características de la pubertad, se considera incorrecta la inclusión de todas ellas en un solo concepto. Esta situación se encuentra en su peor forma en Inglaterra, donde la gran mayoría de los psiquiatras parece haberse aferrado al sentido literal del término, demencia precoz, y haber ignorado, o no comprendido, el concepto básico de esta entidad patológica.

De modo que no nos queda ninguna alternativa excepto la de dar un nuevo nombre a la enfermedad, menos apto para ser malentendido. Tengo plena conciencia de las desventajas del nombre propuesto, pero no conozco ninguno mejor. Es realmente casi imposible encontrar un nombre perfecto para un concepto que todavía se está desarrollando y alterando. Llamo a la demencia precoz «**esquizofrenia**» porque (como espero demostrarlo) el «desdoblamiento» o escisión de las distintas funciones psíquicas es una de sus características más importantes. Por razones de conveniencia, utilizo la palabra en el singular, aunque es evidente que el grupo incluye a varias enfermedades.

Ideas semejantes pueden haber conducido a las sugerencias que hicieran Zweig y Gross. Zweig llamó a la enfermedad «dementia dessecans»; Gross la denominó «dementia sejunctiva». Pero, como ya hemos dicho, el término «demencia» es totalmente inapropiado. En cuanto al término «dementia sejunctiva», debe observarse que el concepto de sejunción, tal como lo utilizó Wernicke, no está definido con la suficiente precisión como para caracterizar adecuadamente la enfermedad. Además, otros autores definen a la sejunción en términos todavía más vagos, de modo que su adopción sólo tendría por resultado discusiones estériles.

Paris ha propuesto el término «psychose catatonique dégénérative». No podemos aceptar tal designación, pues rechazamos la idea de degeneración, y no consideramos esenciales a los síntomas catatónicos. Términos tales como «demencia paratónica progresiva» (Bernstein), «amblythymia» o «amblynoia simplex et catatonica» (Evensen), son completamente unilaterales. La designación de «locura adolescente» (Clouston) es inadecuada desde todo punto de vista. Wolff ha propuesto recientemente «disfrenia», pero este término ya ha sido empleado en otro sentido; tiene además un significado tan amplio que la tentación de interpretarlo mal es demasiado grande. Por las mismas razones no podemos aceptar términos tales como «demencia primitiva» (psiquiatras italianos, Sommer), «dementia simplex» de Brugia, ni encuentro aceptable la «dementia apperceptiva» (Weygandt) de Gross y Weber.

III. LA DEFINICIÓN DE LA ENFERMEDAD

Con el término «demencia precoz» o «esquizofrenia» designamos a un grupo de psicosis cuyo curso es a veces crónico, a veces marcado por ataques intermitentes, y que puede detenerse o retroceder en cualquier etapa, pero que no parece permitir una *restitutio ad integrum* completa. La enfermedad se caracteriza por un tipo específico de alteración del pensamiento, los sentimientos y las relaciones con el mundo exterior, que en ninguna otra afección aparece bajo esta forma particular.

En todos los casos nos vemos frente a un desdoblamiento más o menos nítido de las funciones psíquicas. Si la enfermedad está muy pronunciada, la personalidad pierde su unidad funcional: los diferentes complejos psíquicos parecen actuar de manera autónoma, o bien la síntesis de los diferentes complejos e impulsos falta por completo. Los complejos psíquicos no forman ya un conglomerado de esfuerzos con un resultado unificado como en la persona sana; antes bien, un conjunto de ideas domina la personalidad durante un tiempo, mientras que otros complejos e impulsos son «segregados» y parecen parcial o totalmente impotentes.

A menudo, las ideas son elaboradas sólo parcialmente, y se pone en relación de una manera ilógica a fragmentos de ideas para constituir una nueva idea. Los conceptos dejan de ser completos, parecen prescindir de uno o más de sus componentes esenciales; en realidad, en algunos casos sólo están representados por unas pocas nociones truncadas. De ese modo, el proceso de asociación opera a menudo con meros fragmentos de ideas y conceptos. Esto tiene por resultado asociaciones que individuos normales considerarán incorrectas, extrañas, y totalmente imprevisibles. Con frecuencia el proceso del pensar se detiene en medio de un

pensamiento; o en el intento de pasar a otra idea, cesa súbitamente por completo, al menos en cuanto es consciente (obstrucción o bloqueo). En lugar de continuar el pensamiento, afloran nuevas ideas que ni el paciente ni el observador pueden relacionar de ningún modo con la anterior corriente de pensamiento.

No se pueden demostrar trastornos primarios de la percepción, la orientación, o la memoria. En los casos más graves, parecen faltar completamente las expresiones emocionales y afectivas. En los casos más leves, podemos notar solamente que el grado de intensidad de las reacciones emocionales no guarda proporción con los diversos acontecimientos que han provocado esas reacciones. De hecho, la intensidad de las reacciones afectivas puede variar desde una completa carencia de expresión emocional hasta respuestas afectivas extraordinariamente exageradas en relación con diferentes complejos de pensamientos. La afectividad también puede manifestarse como cualitativamente anormal; esto es, como inadecuada respecto a los procesos intelectuales involucrados (paratimia).

Además de los frecuentemente expuestos signos de «deterioración», en la mayoría de los casos hospitalizados están presentes muchos otros síntomas. Descubrimos alucinaciones, ideas delirantes, confusión, estupor, fluctuaciones afectivas maníacas y melancólicas, y síntomas catatónicos. Muchos de estos síntomas y conjuntos de síntomas accesorios exhiben un carácter esquizofrénico específico, de modo que su presencia puede ser de utilidad para diagnosticar la enfermedad. Fuera del hospital, hay esquizofrénicos en quienes los síntomas accesorios son menos evidentes, o faltan por completo.

En la actualidad, dividimos a la demencia precoz, provisoriamente, en **cuatro subgrupos**:

1. **Paranoide**: Las alucinaciones o ideas delirantes ocupan continuamente el primer plano del cuadro clínico.
2. **Catatónia**: Los síntomas catatónicos dominan continuamente, o durante períodos de tiempo muy largos.
3. **Hebefrenia**: Aparecen síntomas accesorios, pero no dominan el cuadro clínico continuamente.
4. **Esquizofrenia Simple**: A través de todo su curso sólo pueden descubrirse los síntomas básicos específicos.

IV. DELIMITACIÓN RESPECTO A OTROS GRUPOS DE PSICOSIS

La delimitación teórica de la esquizofrenia respecto a otros grupos de psicosis es bastante inequívoca, como lo demostrará rápidamente una revisión de los síntomas que aparecen en otras enfermedades:

1. Las Psicosis Orgánicas:

Comprenden a las que son consideradas manifestaciones de una desintegración difusa de la corteza cerebral (demencia paralítica, demencia senil y, en cierto sentido, la psicosis de Korsakow). Muestran las siguientes características:

- *Aspecto intelectual*: percepciones lentas y poco claras; incapacidad de aprehender completamente problemas complejos, esto es, sólo forman aquellas asociaciones que tienen una relación inmediata con los acontecimientos recientes o el impulso momentáneo; trastornos graves de la memoria, más agudos respecto a los acontecimientos recientes que respecto a los más antiguos. Está fuertemente alterada la orientación en el tiempo, en el espacio y en la situación.
- *Región intermedia*: la atención se ve perturbada, pero el tipo común es afectado generalmente más temprano y más fuertemente que el máximo.
- *Afectividad y Actividad*: se conservan todas las emociones cualitativamente, pero son superficiales, lábiles, inconstantes, e incapaces de dar una dirección duradera a ningún impulso intelectual. Ninguno de estos síntomas es característico de la demencia precoz.

2. Estados Epilépticos:

- *Aspecto intelectual*: La apercepción es afectada de manera similar a la psicosis orgánica, es lenta y borrosa. Las asociaciones son marcadamente egocéntricas, con extrema lentitud en el flujo de pensamiento y la consiguiente dificultad para pasar a otro tema. Hay una tendencia al detalle innecesario, así como hacia un lenguaje perseverativo y perseverancia en la acción. Los trastornos de la memoria aparecen mucho más difusos que en las enfermedades orgánicas. Las amnesias parecen tener límites cualitativamente más nítidos que en las otras dos afecciones. Las facultades intelectuales superiores son afectadas con relativa lentitud y son totalmente congruentes en cualquier dificultad dada.

- *Afectividad*: Gran viscosidad y adhesividad afectiva; estallidos coléricos o estados de éxtasis místico transitorio.
- *Estados motores*: Habla canturreante, vacilante. Los ataques epilépticos convulsivos pueden aparecer en muchas otras afecciones, particularmente en la esquizofrenia. Lo que es característico de la epilepsia no es el ataque individual sino su repetición constante a lo largo de muchos años y el cuadro clínico global que lo acompaña. La demencia precoz no exhibe estos síntomas.

3. La Idiotéz:

Los muchos trastornos a los que denominamos idiotéz tienen en común lo siguiente: comienzan tempranamente, e inclusive en el estado intrauterino, y no manifiestan cambios progresivos considerables. La afectividad es desusadamente variada, pero no difiere esencialmente de la persona sana. En todo caso, el grado de su variabilidad es mayor que el de los individuos normales. No hay depresión afectiva propia. Las asociaciones se limitan a lo que es más obvio intelectualmente. En la demencia precoz tenemos un tipo diferente de trastorno asociativo, así como una perturbación afectiva típica.

4. Paranoia:

La construcción, a partir de premisas falsas, de un sistema de ideas delirantes lógicamente desarrollado, con partes lógicamente relacionadas e inmovibles, sin ninguna perturbación demostrable que afecte a las otras funciones mentales y, por lo tanto, sin síntomas de «deterioración», si se pasa por alto la completa carencia de comprensión, por parte del paranoico, del propio sistema delirante. En la demencia precoz, las ideas delirantes, cuando existen, por lo general muestran crudas, o por lo menos siempre sutiles, violaciones de la coherencia lógica obvia. Además, están presentes los otros síntomas característicos de la demencia precoz.

5. Alcoholismo Crónico y Delirium Tremens:

- *Alcoholismo crónico*: Intelectualmente: cadenas de pensamientos rápidas y superficiales, y una fuerte necesidad de perfeccionar las ideas, especialmente en cuanto a sus relaciones causales. Hay, en particular, una marcada quisquillosidad ante toda insinuación personal, y una gran predisposición a presentar excusas. Afectividad: fácilmente movilizada, efímera, lábil. Correspondientemente, la atención está siempre dirigida a lo momentáneo y carece de resistencia. En las etapas más avanzadas aparecen a menudo signos de trastorno orgánico (atrofia cerebral); de modo que presenta un cuadro que, en todos los detalles, es lo opuesto de la esquizofrenia (sin embargo, son muy frecuentes las combinaciones de ambas enfermedades).
- *Delirium tremens*: Acompañado por un tipo definido de alucinación; un característico estado delirante con la capacidad de «ser vuelto en sí». Afectividad variable, pero congruente en cualquier momento dado, con una corriente subterránea de humor patibulario (*Galgenhumor*).
- *Estados delirantes alcohólicos*: Véase Sección V de este volumen.

6. Amencia y Psicosis Febriles:

La «amencia» de Kraepelin muestra un trastorno muy característico de la percepción y la apercepción. Las psicosis febriles no pueden ser descritas brevemente, en primer lugar porque no han sido estudiadas suficientemente todavía.

7. Formas Maníaco-Depresivas:

El carácter esencial de esta enfermedad reside en un «tono» psíquico generalmente exaltado o deprimido, en lo que atañe a la afectividad, la asociación y la movilidad (euforia patológica, fuga de ideas, actividad apresurada, por una parte; depresión, obstrucción del pensamiento, inhibición motriz general, por otra). Están ausentes los síntomas específicos de otros grupos de enfermedades, como la deterioración en el sentido en que se usa en la esquizofrenia. Lo que denominamos ordinariamente deterioración en la locura maníaco-depresiva es la incontinencia emocional o la obstrucción mental depresiva, o la demencia adicional debida a atrofia cerebral. En los casos de demencia precoz, encontramos no raramente síntomas positivos de perturbación maníaco-depresiva, pero complicados con las características específicas de la demencia precoz.

8. Histeria:

Los síntomas esenciales, y en particular el curso de la enfermedad, pueden explicarse en términos de factores psicogénicos como una exageración de ciertas ideas teñidas afectivamente. Sin embargo, no hay deterioración ni síntomas específicamente

esquizofrénicos. En la demencia precoz podemos encontrar síntomas histéricos, pero exhiben una coloración marcadamente esquizofrénica, parecen caricaturizados, y aparecen en combinación con síntomas específicos de esta enfermedad.

Conclusión de la Introducción:

En estas dos afecciones, la psicosis maníaco-depresiva y la histeria, y en un cierto sentido quizá también en la paranoia, nos hemos familiarizado hasta ahora sólo con síntomas que pueden aparecer asimismo en la demencia precoz. La diferencia entre ésta y aquellas psicosis consiste esencialmente en un **excedente de parte de la demencia precoz**: la escisión asociativa básica, el autismo y la alteración cualitativa de la personalidad. Todos los otros estados psicóticos manifiestan síntomas específicos que no aparecen en la demencia precoz.